

病診連携カンファレンス

生活破綻型救急から紐解く、 真の地域包括ケアについて

— 救急医療が出口とされない社会を目指して—

みなさんは、
自分の生き方、過ごし方、死に方を、
他人に決められたいと思いますか？

1%未満

- ・ 終末期の定義
- ・ 終末期宣告
- ・ ACP
- ・ 尊厳
- ・ 自己決定

病院の取り組みとして、どの程度できているのでしょうか？

日本社会には『死を語らない文化』がある

そしてこれは = 『生を意識しない文化』であり

= 『生に目的を持たない文化』である

目的がないことで、

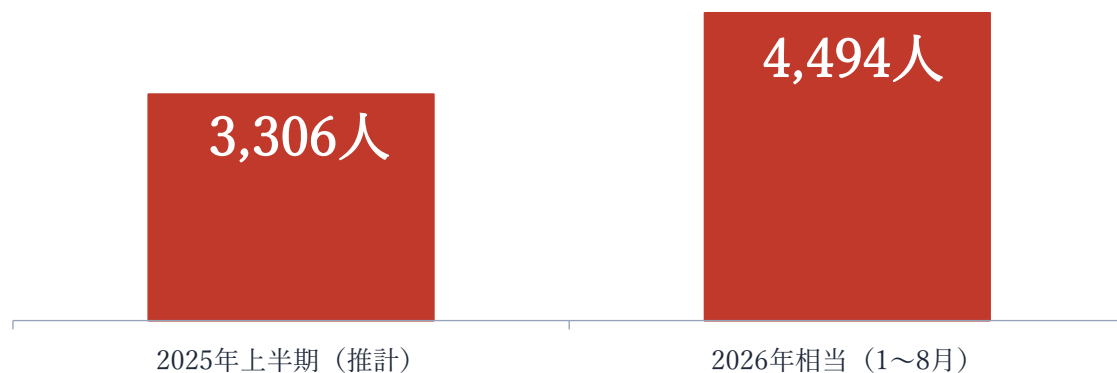
- ・ 主体性が生まれない
- ・ フレイルが進行する

- ・ 行動の必然性が起きない
- ・ 生活が維持できない

目的がないことで、生活は維持できなくなる

対象期間：2025年-2026年（提供データ表記に準拠）

救急搬送人員（人）

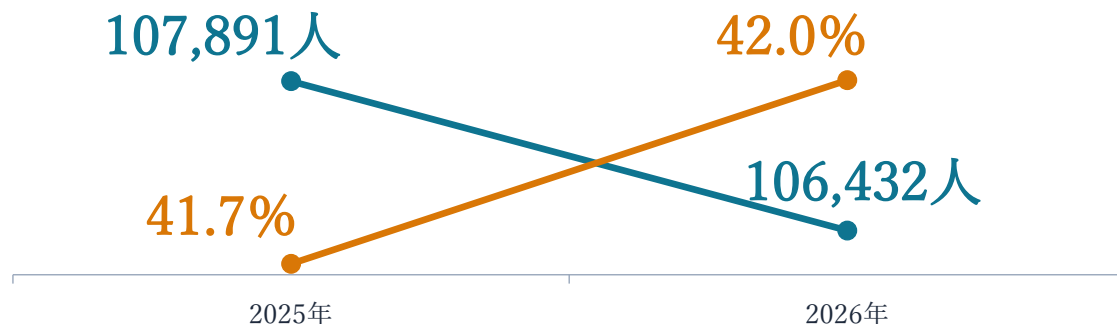


救急搬送数は35.9%増

救急搬送人員数

3,306人 → 4,494人

総人口（人）と 高齢化率（%）



総人口は1,459人減

総人口

107,891人 → 106,432人

高齢化率は0.3pt増加し、42%へ

高齢化率の上昇

41.7% → 42.0%

現状① 人口動態

人口は減り、高齢者の比率は増えている

現状② 救急搬送

救急搬送は増えているが、実は重症搬送数自体は増えていない

結論

高齢者が増えて、軽症搬送が増え続けている



生活破綻型救急

① タクシー代わりの利用

- ・いつでも無料
- ・必ず医療機関に連れて行ってくれる
- ・夜間・休日でも確実
- ・家族がいないから

→ 移動手段として救急車が簡単に選ばれる

② 行き先がわからない（判断力・支援力低下）

- ・判断力の低下（MCI・認知症）
- ・どこの医療機関に行けばいいかわからない
- ・相談相手がいない
- ・安心感

→ “わからないから救急車”という構造

③ 医療・介護・CM・施設・家族の誘導（構造的問題）

- ・夜間対応ができない
- ・保身による医療搬送
- ・CMの対応限界
- ・受け入れ先を探すのが大変

→ “安全第一、命の保証＝救急”という構造

④ “急変”という名の事後対応

- ・熱が高い／自力で動けない
- ・食事・水分が取れない
- ・認知機能低下で状況説明ができない
- ・久しぶりに見たら急激に悪化していた

→ 問題が起きたことに誰も気づかず
気づいた時点での事後対応

生活破綻 = 日常生活が成り立たなくなること = 生活機能の連鎖的崩壊

生活の基本

- ・ 食べる
- ・ 動く
- ・ 排泄する
- ・ 寝る

生活周辺動作

掃除・片づけ / ごみを出す
コミュニケーションをとる
服薬管理 / 水分摂取
危険回避

○ 生活破綻の本質

身体的・精神的・社会的な問題が連鎖的に破綻していく状態

全般的低下 → 代償 → 限界 = 生活破綻

1 全般的低下

全体的に低下する
体積に依存し下肢優位の低下
体重減少など、
変化は緩やかに進む

2 代償

残っている一部の機能が
低下した機能を補う

本人にも家族にも
「まだできる」ように見える

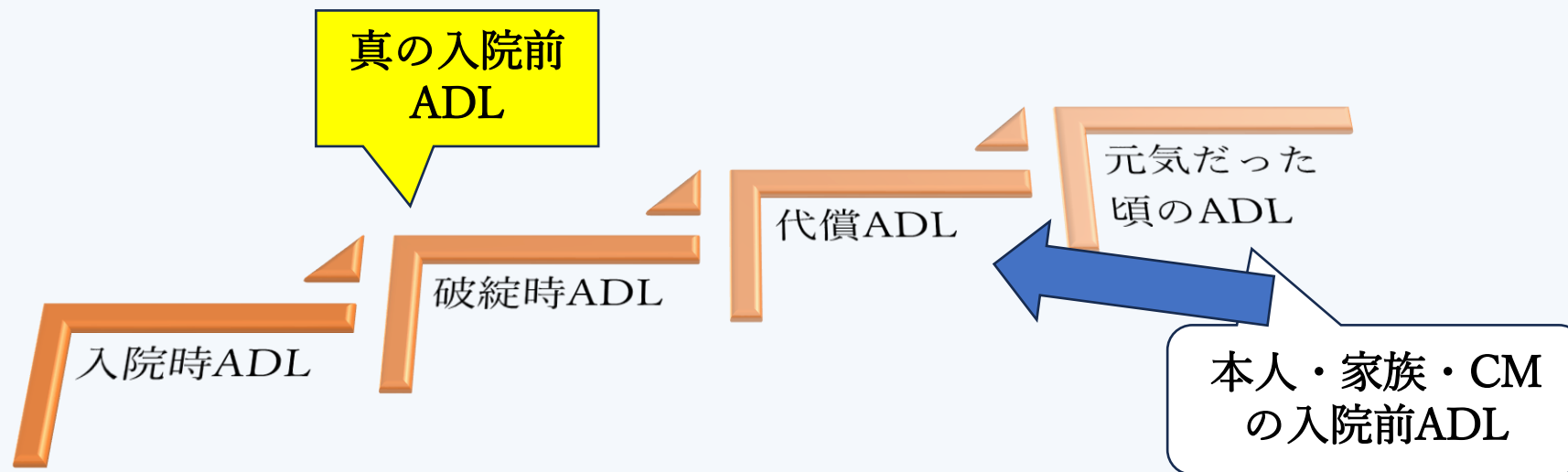
3 限界 = 生活破綻

代償が限界を迎えると
能力が急激に低下する

急速に低下し、
突然できなくなったように見える

本人「できているつもり」 / 家族「できていた」

破綻直前まで「できている」ように見えるため、本人も家族も変化を見誤りやすい



「入院前ADL」を元気だった頃の機能と捉えてしまっている
「実際の入院前ADL」は、すでに生活破綻を起こした後のADLである

「入院で落ちた」のではなく、入院前から生活は崩れている

病態は軽症

疾患治療は比較的スムーズに完了する

しかし、生活が破綻している

“生活機能が壊れている”という問題が中心に

結果、

- ・リハビリは長くかかる
- ・自宅でのサービス調整に長時間を要する
- ・自律性が崩壊していれば施設調整が必要

→ 重症患者と同様・以上に、時間と労力がかかる

- 急性期ベッドが埋まる
- 入院が長期化する
- 医療・介護財政を圧迫する
- 昼夜問わずやってくる
- 家族説明に時間を要する
- 救急医療に莫大な負荷を生んでいる

生活破綻は急性期ベッドを埋め、入院を長期化させ、医療・介護財政を圧迫する
それを救急医療という急性期の最前線が担わなければならない構造

生活破綻は、救急医療の持続性とまちの持続可能性を奪う構造

本人は助けを求められない 基本、助けは相談ありき

支援の仕組みがあっても、本人が相談できなければ支援にはつながらない

なぜ助けを求められないのでしょうか？

Agency：主体的決定能力、主体性

自らの意思で、判断・選択し、それを行動に移す能力

= 生活を営む力

生活破綻は、Agency（主体的決定能力）の低下・喪失に基づく

- ・ 目的がなくなる
- ・ 自助の活動がなくなる
- ・ 意思が曖昧になる
- ・ 助けを求められなくなる
- ・ 危機を認識できなくなる
- ・ 行動できなくなる

→ 気付かぬうちに生活は破綻していく

フレイルの再定義：「衰え」ではなく「生活破綻の手前」

従来の定義

加齢に伴い心身が衰えた状態
(要介護)

Robust (健常) $\leq$ Frailty (フレイル) < Disability (要介護)

逆定義 → 生活破綻未満の状態をフレイルと定義

- ・ 生活のセルフマネジメントができなくなりつつある状態
- ・ 生活破綻の手前
- ・ 介護保険の対象外 = 【空白の層】 → **フレイル：生活破綻予備軍**

○ 生活の段階と制度



Robust

Frailty

生活破綻

Disability

Agency

Agencyの低下により、

- ・ 危険を認識できない
- ・ 言語化できない
- ・ 他者に伝えられない
- ・ 助けを求めるという選択肢が浮かばない

※ 本人の性格や怠慢によるものではない

→ つまり、生活破綻目前の人は、助けが求められない

Disability = Agencyの喪失 = 自律生活不能

※ 要介護と定義することでフレイルの定義自体が形骸化してしまっている

Agencyを喪失すると、

- ・判断できない
- ・選択できない
- ・段取りできない
- ・優先順位がつけられない
- ・意欲がない
- ・生活の方向性（目的）がなくなる
- ・自己決定ができない

生活破綻の時点で Agency はほぼ枯渇し、意思決定そのものができなくなる

➡ 自ら生活を営むことはできなくなる（生活のDisability）

生活破綻 → Disability → Lifeの決定権の移譲

- ・ Agencyが喪失すると、自分のLife（生活・命）の決定権が家族に移譲される
- ・ 延命するか / どこまで医療を行うか / どこで最期を迎えるか

「自分の生き死にの判断を、自分の子供にさせる」

家族が苦しみ、社会が歪む — それが今の社会である

だからこそ、ACP：Advance Care Planningが必要

ACPが守るもの

- ・ 本人の尊厳 / 意思
- ・ 家族の過剰な判断責任の負担軽減
- ・ 医療・介護の過剰介入の回避
- ・ 社会の持続性

ACPとは、本来、「死の話」ではなく「生の話」

ACPを単独で議論すると、
死に方を決める話し合い＝出口戦略と誤解されてしまう

だからこそ、まずは、
『どう生活し、どう生きたいか』から言語化し、
『生活に目的を持つ』ことから始めなければならない

ALP : Advance Life Planning

ALP : 生活と人生の目的の言語化

○ ALPの構成要素

- ・ 生活の目的
- ・ 生活の場の選択
- ・ 役割の維持
- ・ 人間関係
- ・ 健康の維持
- ・ 生活の価値観
- ・ 危機管理
- ・ 資金管理

➡ 生活・人生の設計図そのもの

目的・必然性があるから、判断を行動に移す力（Agency）が働き、
運動・食事・社会参加・生活リズムなどの自助（Autonomy維持）につながる

目的・必然性がなければ、
判断の根拠・選択の基準・行動の理由・継続の動機が曖昧になり、
Agencyは使われないまま衰退し、やがて枯渇する

→ 目的地のない航海と同じ：漂流し、やがて座礁する

- ① 自助の途絶 運動・食事・社会参加・生活リズムが維持されず、Frailtyが進行する
- ② Agencyの枯渇 意思・価値観・生活の方向性を言語化できず、意思決定が難しくなる
- ③ 家への固執 それは意思ではなく環境変化への拒絶反応
「意思のように見える非意思」が調整を難渋させる
- ④ 環境の中での漂流 与えられた環境の中で行動の理由も人間関係も生まれず、
自ら選ばない限りAgencyは回復しない＝依存

➡ 目的なき老後は、生活破綻へと一直線に進む

目的を持つことで、主体性が生まれ、自助につながる
自らで達成できなければ、地域全体で支えていく

 地域包括ケア

- ・ 目的を明確化することで、本人・家族・医療・介護・地域が同じ方向を向くことができる
- ・ 本人のAgencyと、本人が決めた生活の目的（ALP）
- ・ その目的達成が困難化してきたときに、ACPが必要となってくる
- ・ あらかじめ限界を共有し、治療からケアへと移行し生活を継続できるように準備しておくこと

それこそが、本来のAdvance Care Planning

ALPからACPへ：生活を継続するためのバトントス

生活が守れず、地域包括ケアが実践できない構造的な原因

生活が守れない最大の原因は、「医療の縦割り構造」

- ・ 医学＝疾患の原因を解明し治療する学問 / 医療＝疾患を治療する行為
- ・ どこにも「生活を守る」「生活を治療する」という定義は存在しない
- ・ だから多くの医療者に、生活を見る・生活を守る・生活を治療するという視点がない
- ・ さらに医療は長年「疾患別の縦割り」で運用されてきた
(専門内はとことん治療、専門外は専門へ)
- ・ しかし、患者は「疾患の集合体」ではなく「一人の生活者」である

➡ 縦割り医療は、「一人の生活者」として診ていない

治療

goal=疾患の治療・コントロール

- ・病気を治すことで生活の持続性を得る側面はある

一方で、

入院・臥床による体力／筋力低下、絶食・前処置、副作用、せん妄、Agencyの低下

- ・生命力を削り、生活を壊す側面を併せ持つ

ケア

goal=生活の継続（疾患の治療ではなく、最小限のコントロールを目指す）

- ・生活を支える / 生命力を守る / 生活破綻を防ぐ
- ・QOL・QODを守る / ACPにつながる
- ・患者の生活に寄り添う

生活を守る医療とは、治療ではなくケアである

医師の goal

疾患の治療・コントロール

看護・リハ・MSW・CM・介護職・本人の goal

生活の保全（生活の継続）

同じ患者に向き合っているにもかかわらず、担う役割と目指す到達点は同じではない

◎だからこそ、多職種連携が重要

生活保全を推し通すためには、医師中心構造ではなく、

生活中心構造を支える多職種連携が不可欠になる

医療は、疾患治療だけでは完結せず、生活が守られなければ成立しない

若者

治療すれば生活が戻る

『疾患治癒』 = 『生活保全』

そのため、治療価値は自然に高くなる

高齢者

『疾患治癒』 ≠ 『生活保全』

疾患の治癒・コントロールと
生活保全の両立が成立しない場合が多い

治療だけでは、高齢者の生活は守れない



生活保全の重要性

「生活を見る・生活を守る医療」とは

- ・患者の「生活の方向性（ALP）」を中心に医療を組み立て、
その生活を継続できるように支える医療
- ・どこでどのような暮らしを続けたいか / 何を大切にしたいか
- ・どんな役割を持ち続けたいか / どんな生活を守りたいのか

疾患中心ではなく、生活中心の医療 = ACPこそが、生活を守る医療の中心にある

医療は生活のための手段であり、生活の継続こそがゴール

- ・ **ALP**：本人に目標がなければ、生活は維持できない
 - ・ **自助**：本人が努力しなければ、生活は維持できない
 - ・ **Agency**：本人に主体性がなければ、何も決められない
- ➡生活には、『目標』『努力』『主体性』が不可欠

○ACP：生活の継続性が危ぶまれてきたらどうするか

- ・ 生活を守る介護：本人の主体性・能力をサポート
- ・ 生活を守る医療：治療よりも生活を守ることに重点を置いた医療へのシフト

頑張る本人を皆でどう支えるかを共同で考え、実践していく

➡ 生活の場を中心とした支援こそ、真の地域包括ケア

29 自分の生き方・過ごし方・死に方を、他人に決められたいですか？

- ・ 目的がない
- ・ Agencyがない
- ・ ACPは成立しない

➡ 生活破綻により、救急へと流れ着き、生活を失う

これは制度の問題だけでなく、文化の問題『死を意識しない・語らない文化』

= 生を意識しないこと、目的を持たないこと

- | | |
|----------------|---------------------|
| ・ 必然性が生まれない | ・ 生活が破綻する |
| ・ 自助が途絶える | ・ ACPが成立しない |
| ・ Frailtyが進行する | ・ 終末期の過ごし方を他人に決められる |
| ・ Agencyが枯渇する | ・ 尊厳が失われる |

“個人の損失”だけでなく“社会の損失”

個人の損失

- ・ ALPがない → 自助途絶 → Frailty進行 → Agency枯渇 → 生活破綻
→ 救急医療 → 生活を失う（Disability） → 自己決定のない終末期：尊厳の喪失

社会の損失

- ・ 医療・介護費が膨張し続ける：増え続ける社会保障費・減り続ける若者
- ・ 社会的資源（在宅医療・介護福祉サービス）の枯渇
- ・ 病院の活力が低下：バーンアウト / 救急医療の維持困難 / 病院経営悪化



→ このままでは社会の持続性も奪う構造

小樽は、高齢化率42%、2040年問題を先取る都市

だからこそ、「生命中心」から「生活中心」へ
医療と介護の目的・核を、生活へと変える必要がある

- ・生活を意識する
- ・目的を意識する
- ・フレイルと生活破綻を意識する
- ・社会の一員として『生きること』を意識する：Social inclusion
- ・生と死を意識する
- ・限界を意識する
- ・自助・互助・社会参加を意識する

医療も生活を守るために、介護も生活を守るために

生活を守る医療・介護を行うため、地域包括ケアを実践していくためには、
『生活を合言葉に、生活の連続性を守るための医介連携・病診連携を再設計すること』

その中心になるのは、『Primary care』

Primary care医を中心として、病診連携を駆使して行うべき5つの取り組みを提示します

- I Primary care：生活の責任主体
- II 終末期：生活の限界の共有と判断
- III 多科診療・Polypharmacy：生活を壊す構造の見直し
- IV 病診連携：生活という共通言語
- V 地域包括ケア病棟：生活の再出発点、の有効活用

生活保全医療の責任者：Primary Care 医を作る

高齢者に対しての疾患別・臓器別診療

→責任が分散し、生活全体を誰も見なくなる構造

かかりつけ医がPrimary care医を担い、責任の主体を担う

○ACCCA : primary careの機能定義

- ・ Accessibility : 生活の困りごとに最初に対応
- ・ Comprehensiveness : 生活の問題を包括的に扱う
- ・ Coordination : 生活が途切れないように支援をつなぐ
- ・ Continuity : 変化に合わせて生活を継続させる
- ・ Accountability : 責任者、主治医

かかりつけ医は外来主治医であり、Primary care医であるべき

終末期とは、『生命予後が限られ、不可逆的な病状で治癒の可能性が乏しい状態』

Agencyが残されている人は、何を望むのか

- ・ 苦痛の除去とQOLの維持
- ・ meaning-making：人生の振り返りと意味づくり
- ・ relationship completion：関係の締めくくり
- ・ self-continuity：自分らしさの保持
- ・ 最後のACP：生活の中での連続性と生活の締めくくり

Doctor's Question (Surprise Question)

“Would you be surprised if this patient were to die in the next 6–12 months?”

- ・ 残された時間の有効活用
- ・ 本人の価値観の確認とACP
- ・ 家族の心構えを整える
- ・ 過剰な治療・厳格なコントロールを止める
- ・ 生活の締めくくりを行う余白を作る
- ・ 本人の希望する場所での最期を準備する

●多科診療の構造的問題

診療科が増えるほど、生活についての責任は分散し、誰も生活をみなくなる
移動負担、待ち時間負担、説明の分断、polypharmacyが必発

→生活の限界が早まる、生活破綻型救急を産みだす構造

●PolypharmacyとDeprescribing

相互作用 → 副作用の増加 → 機能低下 → 更なる薬の使用という悪循環

多科受診がpolypharmacyを生み、polypharmacyがさらなる多数科受診を必要とする

『フレイルへのガイドライン遵守薬剤は、生活破綻へと背中を押す行為となりうる』

→疾患や臓器ではなく、その人に対してのDeprescribingが必要

治療の優先順位を生活という観点から再構成する必要がある

●役割分担

かかりつけ医＝生活の責任主体：ACCCA

病院＝疾患治療＋生活保全

→この役割分担が崩れると、生活破綻型救急が起きる

●相互補完

かかりつけ医の限界、病院の限界をしっかりと共有し、生活を守ることを最優先とする
多数科診療の是正、Polypharmacyの是正、生活に向けての最適化を病院が担う

→生活の連続性を担保する連携こそが、地域包括ケアの中核

地域包括ケア病棟は『治療後の生活を再構築するための場』

- ・生活機能の評価
- ・治療後の生活への適応
- ・多職種による生活再建
- ・ACPの再構築
- ・自立支援の方向性決定
- ・退院後の生活設計とかかりつけ医や在宅サービスとの連携

長く元気に家で生活できるように、有効活用すべき

地域包括ケア病棟は、

- ① 病名を問わない
- ② 繰り返し利用できる
- ③ 医療と生活の両立が可能
- ④ ケアプランの見直し、在宅リハ(自助の方向性)の見直しが可能 など

自分らしい生活ができなくなる前に、
できていたことができなくなる前に、
Agency：主体性を失う前に、

繰り返し介入することこそが本来の利用価値



退院後地域包括ケア連携事業が担うこと

- 生活目標・治療方針・生活課題を共有
- 訪問診療・訪問看護・リハ介護・デイサービスへと接続
- 退院後の変化を把握し、再破綻を防ぐ

退院を「終点」から、地域包括ケアへの「入口」へ

退院を終点にせず、病院から地域包括ケアの路線へ確実に接続する

病診連携カンファレンス

配布資料

— 生活を守る、Evidence —

生活破綻型救急は構造的な需要

根拠	スライドで押さえるポイント
消防庁 令和7年版 救急・救助の現況	2024年の救急出動件数・搬送人員は、ともに集計開始以来最多。高齢化を背景に救急需要は増え続けている。
厚生労働省 地域医療構想資料 2025	2020年から2040年に、85歳以上の救急搬送は75%増加すると推計。医療・介護の複合ニーズへの地域対応を課題とする。
WHO-APO 2018/OECD 2019	人口高齢化、医療費増大、資源の需給ミスマッチを日本の構造課題として示し、地域包括的な改革の必要性を指摘する。

救急需要の増加は、個人の疾患だけでなく生活と制度の構造から生まれる

Primary careが生活を守る

根拠	スライドで押さえるポイント
Starfield Primary Care 1998	初回接触、継続性、包括性、協調性を核に、疾患ではなく人を長期にみるPrimary careの機能を体系化した。
Haggerty et al. Ann Fam Med 2013	複数の医療者にかかる患者にとって、信頼できる一人の臨床家がナビゲートすることが継続性の基盤になる。
WHO People-centred care 2016	疾患・施設中心から、人の包括的ニーズと選好を中心に調整されたケアへの転換を求める。

ACCCAは、生活を継続して支えるための実装機能

ガイドラインの足し算では生活を守れない

根拠	スライドで押さえるポイント
ADA Older Adults 2026	機能・社会面まで包括評価し、低血糖、転倒、フレイル、ポリファーマシーを踏まえて目標を個別化する。
KDIGO CKD 2024	患者中心のケアと薬剤スチュワードシップを重視し、個々のリスク・価値観・治療負担に応じて方針を調整する。
NICE Multimorbidity NG56	疾患別管理の累積が治療負担になり得るため、本人の目標を起点に治療を最適化し、有害な介入を減らす。

疾患別ガイドラインは「一つ的手段」であり、生活を守るためには最適化が必要

高齢者医療のアウトカムは数値だけではない

根拠	スライドで押さえるポイント
NICE Multimorbidity NG56	本人の価値観・目標・治療負担を確認し、日常生活で優先することによってケア計画を組み直す。
AGS Multimorbidity Principles 2012	患者の選好、予後、実行可能性を統合し、期待利益を最大化しながら害と負担を最小化する。
WHO ICOPE 2017	高齢者のニーズと選好を中心に、内在的能力と生活機能を維持する統合ケアを推奨する。

数値の改善だけでなく、機能・自立・生活の質を中心に置く

縦割り診療は治療負担と分断を生む

根拠	スライドで押さえるポイント
Tinetti, Fried & Boyd JAMA 2012	単一疾患を前提とした医療設計はmultimorbidityに適合しにくく、患者にとって重要な目標を軸に再設計する必要がある。
NICE Multimorbidity NG56	複数の治療・受診による負担を評価し、ケアの調整と優先順位づけによって重複や矛盾を減らす。
WHO People-centred framework 2016	病院中心・疾患中心・サイロ型のモデルは、質・連続性・持続可能性を損なうとして統合を求める。

専門性を束ねる「生活の責任主体」が必要になる

Polypharmacyは生活機能を損なうリスクになる

根拠	スライドで押さえるポイント
Scott et al. Med J Aust 2014	不適切な多剤併用は、身体機能低下、転倒、せん妄、入院、死亡と関連する。減薬は患者中心のケアとして位置づけられる。
Scott et al. JAMA IM 2015	適応・利益と害・本人の優先事項を順に確認する、構造化された deprescribing プロセスを提示。
WHO Medication Without Harm 2017	薬剤関連の回避可能な害を世界的課題とし、処方からモニタリングまでシステム全体の安全対策を求める。

薬の数が生活を壊し、生活上の利益と害から、処方全体を見直す

終末期についてのDoctor's Question (Surprise Question)

根拠	スライドで押さえるポイント
GSF Prognostic Indicator Guidance (PIG)	終末期判定の中心となる「Doctor's Question (Surprise Question)」を公式に定義。患者の予後認識を促し、早期のACP導入を可能にする。
BMJ Supportive & Palliative Care (2025) Gold Standards Framework implementation in an acute hospital: end-of-life outcomes	GSFを急性期病院で実装し、Surprise Questionを含む終末期判定プロセスの有効性を検証。ACP実施率の向上と病院死の減少を示した。

終末期を定義し、しっかりと準備期間を作っていくことが重要

出典：GSF PIG／BMJ Supportive & Palliative Care 2025

「生活保全」のための介入：フレイルケア

根拠	スライドで押さえるポイント
WHO ICOPE 2017	身体・精神能力の低下を予防・遅延・回復させるため、地域での包括評価と統合的介入を推奨する。
SPRINTT BMJ 2022	身体活動と栄養を組み合わせた介入で、フレイル高齢者の移動能力障害を主要アウトカムとして検証した。
Dent et al. Lancet 2019	個別化した介入によって、自立、身体機能、認知機能を保つ方向への転換を提言する。

治療の終了は、生活機能を再構築する再出発点

出典：WHO ICOPE 2017／Bernabei et al., BMJ 2022／Dent et al., Lancet 2019

小樽フレイルケアプロジェクトの概要はこちら➡
※本日の講演内容は、1か月後を目標に掲載します

